



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**LAPORAN TRIWULAN I
KOMITE PPRA
BULAN JANUARI – MARET
TAHUN 2026**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0341 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya penyusunan Laporan Triwulan I Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba tahun 2026 ini dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu sehingga dapat dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan Pemilik Rumah Sakit Prima Husada (PT. Disa Prima Medika).

Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba dilakukan berdasarkan tersedianya data audit penggunaan antibiotik. Data yang tersedia yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Kedua data tersebut saling berkesinambungan untuk dapat menilai apakah penggunaan antibiotik Rumah Sakit sudah tergolong rasional atau tidak. Hasil audit kuantitatif dan kualitatif dapat dijadikan penilaian terhadap seluruh SMF terkait pemberian antibiotik didasarkan pada PPAB (Panduan Penggunaan Antibiotik).

Dengan tersusunnya Laporan Pengendalian Pencegahan Resistensi Antimikroba ini, kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah membantu terselesaikannya laporan ini sehingga dapat dipergunakan untuk pendekatan sistemik dalam hal aplikasi proses dan pengetahuan yang seragam dalam melaksanakan semua kegiatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.

Penyusun

I. SDM

Jumlah SDM bulan ini :

Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	Januari - Maret	Kebutuhan	
Ketua PPRA	1	1	0	
Sekretaris	1	1	0	
Anggota	15	15	0	

II. Pemenuhan kualifikasi SDM

Jabatan	Nama	Pendidikan		Pelatihan	Keterangan
		Standar	Kondisi saat ini		
Ketua	dr. Brilliant Margalin, Sp.PK,MARS	S1	Spesialis Patologi Klinik	Pelatihan PPRA Eksternal	Terlaksana
Sekretaris	Nur Intan Permatasari, S.Farm., Apt.	S1	Apoteker	Pelatihan PPRA Eksternal	Terlaksana
Anggota	dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An	S1	Dokter Anestesi	In house training tahun 2024	Terlaksana
	dr. Rudi Priyo Utomo, Sp. OG	S1	Dokter Obstetri dan Ginekologi	In house training tahun 2024	Terlaksana
	dr. Rossy Zaki Sp. B	S1	Dokter Bedah	In house training tahun 2024	Terlaksana
	dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp. OT	S1	Dokter Bedah	In house training tahun 2024	Terlaksana
	dr. Novita Maulidiyah, Sp.P	S1	Dokter Paru	In house training tahun 2024	Terlaksana
	dr. Muhammad Irawan, Sp.A.	S1	Dokter Anak	In house training tahun 2024	Terlaksana
	dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD	S1	Dokter Ilmu Penyakit Dalam	In house training tahun 2024	Terlaksana
	Risky Dwi Ramadhani, Amd.Kep	S1	Perawat Bedah / IKO	In house training tahun 2024	Terlaksana
	Shinta Aprilia Rizky, S.Farm., Apt	S1	Apoteker	Pelatihan PPRA Eksternal	Terlaksana
	Avivatul Khoiroh, S.Farm., Apt.	S1	Apoteker	In house training tahun 2024	Terlaksana

	Dita Nurul Aini S.Farm., Apt.	S1	Anggota KFT	<i>In house training tahun 2024</i>	Terlaksana
	Elza Safarina Ulfa, Amd, AK	S1	Petugas Laboratorium	<i>In house training tahun 2024</i>	Terlaksana
	Aulya Wahyuningrum Rena Dumilah, Amd.Kes	S1	Petugas Laboratorium	<i>In house training tahun 2024</i>	Terlaksana
	Dwi Siska Hardyanti, S.KM	S1	Komite PPI	<i>In house training tahun 2024</i>	Terlaksana
	Lidia Puspita Kencana, S.KM	S1	Komite Mutu	<i>In house training tahun 2024</i>	Terlaksana

III. Program Kerja dan Pengembangan Pelayanan

No.	Kegiatan pokok	Rincian Kegiatan
1.	Peningkatan pemahaman mengenai PPRA kepada seluruh tenaga kesehatan dan staff rumah sakit.	- Sosialisasi terkait penggunaan antibiotik secara bijak kepada PPA RS Prima Husada Sukorejo - Sosialisasi tentang penggunaan antibiotik yang bijak serta program kerja PPRA kepada staff farmasi RS Prima Husada Sukorejo - Sosialisasi tentang penggunaan antibiotic yang bijak kepada pasien dan keluarga pasien (rawat inap dan rawat jalan) - Sosialisasi penggunaan antibiotik yang bijak kepada masyarakat melalui media sosial RS Prima Husada Sukorejo
2.	Optimalisasi penggunaan antimikroba secara bijak melalui penerapan PGA (Penatagunaan Antimikroba)	- Menerapkan sistem formularium antibiotik dan daftar antibiotik terbatas - Mewajibkan pengisian formulir PGA sebelum pemberian antibiotik tertentu - Melakukan audit dan feedback berkala terkait pola persepan antimikroba.
3.	Survailens penggunaan antimikroba secara kuantitatif dan kualitatif	- Mengumpulkan data pemakaian antibiotik dari farmasi, rekam medis, dan SIMRS berdasarkan jenis, jumlah, dan unit pelayanan. - Analisis penggunaan antibiotic secara kuantitatif (DDD/100 bed days) dan kualitatif (audit ketepatan indikasi, dosis, durasi) - Menganalisis pola penggunaan antibiotik berdasarkan golongan dan jenis antibiotik.

		- Menyusun laporan tren penggunaan antibiotik per bulan - Melakukan evaluasi kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai panduan klinis
4.	Survailens resistensi antimikroba dengan indikator mikroba MDRO	- Melakukan pemantauan terhadap kejadian infeksi oleh mikroorganisme resisten (MDRO), seperti ESBL dan MRSA. - Untuk laboratorium yang belum dapat mengindentifikasi ESBL/MRSA, tetap memantau MDR (resisten terhadap $\geq$ 3 golongan antibiotik). - Mengintegrasikan data resistensi dengan data klinis untuk mendukung pengambilan keputusan terapi.
5.	Peningkatan mutu penanganan tata laksana infeksi melalui pelaksanaan forum kajian kasus infeksi	- Menentukan kasus infeksi yang akan dikaji, terutama kasus dengan penggunaan antibiotik spektrum luas, multidrug - Mengumpulkan data rekam medis, hasil laboratorium, kultur dan uji sensitivitas, terapi antibiotik, serta perkembangan klinis pasien. - Persiapan forum kajian kasus dan Menyelenggarakan forum kajian kasus terintegrasi (FORKKIT) secara rutin. - Melibatkan dokter klinis, apoteker, mikrobiologi, dan perawat dalam diskusi kasus. - Merumuskan perbaikan tata laksana infeksi dari hasil FORRKIT dan memasukkan ke dalam kebijakan rumah sakit

IV. Fasilitas

No.	Kegiatan Pokok	Keterangan
1	Ruang Komite PPRA	Mengajukan ke pihak manajemen

V. Indikator Mutu dan Keselamatan Pasien PPRA

No.	Indikator Mutu	Standar
1	Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada	-
2	Audit penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)	$\geq$ 50%
3	Surveilans pola kuman dan kepekaan antibiotika	-
4	Audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif	-

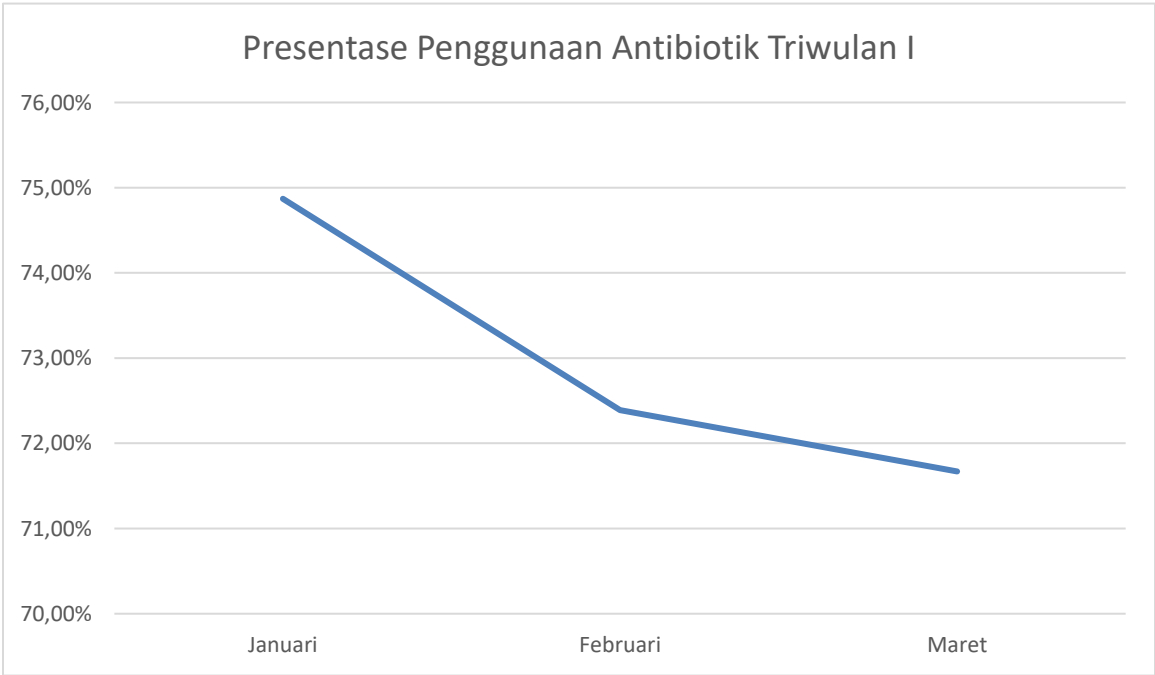
VI. **PENCAPAIAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN PPRA TRIWULAN I**

6.1 Hasil Surveilans audit Kualitatif dan Kuantitatif PPRA Triwulan I

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo
- a. Tabel Surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo

No.	Bulan	Prosentase
1	Januari	74,87 %
2	Februari	72,39 %
3	Maret	71,67 %

- b. Grafik surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS Prima Husada Sukorejo



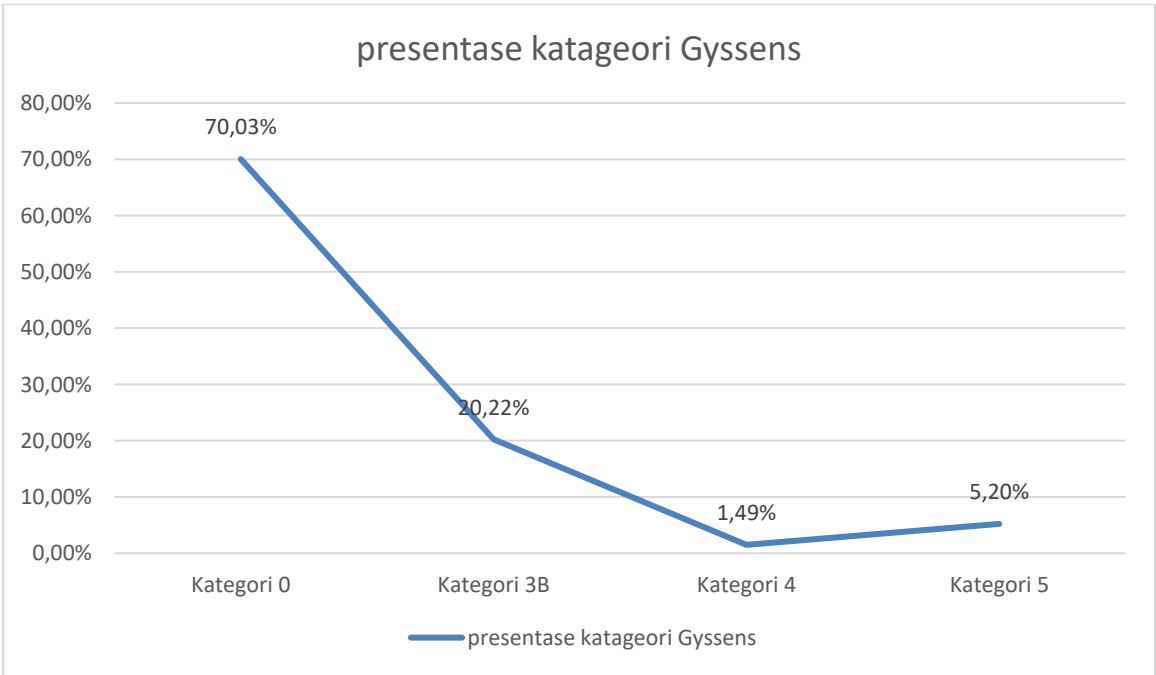
- c. Analisa surveilans penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara keseluruhan di RS PrimaHusada Sukorejo
- Berdasarkan hasil surveilans penggunaan antibiotik di RS Prima husada pada Triwulan I Tahun 2026, diperoleh presentase penggunaan antibiotik sebesar 74,87%
 - Penggunaan antibiotik pada bulan Januari 74,87 %, pada bulan Februari sebesar 72,39 %, dan pada bulan Maret sebesar 71,67%. Rata-rata capaian selama Triwulan I adalah 72,98%
 - Terjadi tren penurunan penggunaan antibiotik dari Januari hingga Maret dengan penuruanan sebesar 3,20%
 - Penurunan ini dapat menggambarkan adanya upaya pengendalian penggunaan antibiotik yang mulai berjalan, seperti pelaksanaan program PPRA, penerapan pra-otorisasi antibiotik, audit penggunaan antibiotik, serta peningkatan kepatuhan terhadap pedoman penggunaan antibiotik di rumah sakit.
 - Belum ada target atau standar penggunaan antibiotik di Rumah Sakit.
 - Pengambilan data berdasarkan SIMRS.

2. Audit penggunaan antibiotika di Rawat Inap secara kualitatif (Gyssens)
- a. Tabel audit penggunaan antibiotika di Rawat Inap secara kualitatif (Gyssens)

No	Kriteria Gyssens	Standar	%
			Januari-Maret
1	Katagori 0	≥ 50	73,03 %
2	Katagori 1	0	0
3	Katagori 2A	0	0
4	Katagori 2B	0	0
5	Katagori 2C	0	0
6	Katagori 3A	0	0
7	Kategori 3B	0	20,22%
8	Kategori 4	0	1,49 %
9	Kategori 5	0	5,2 %
10	Kategori 6	0	0

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa kriteria Gyssens data penggunaan antibiotik bulan Januari-Maret yang dapat dibandingkan adalah kategori 0, kategori 3B, kategori 5 dan , yang ditunjukkan lebih lanjut pada grafik di bawah ini.

- b. Grafik audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara Kualitatif (Gyssens)



- c. Analisa penggunaan antibiotika secara kualitatif (Gyssens)
1. Pada triwulan I, nilai tertinggi pada kategori 0 yaitu penggunaan antibiotik tepat dan rasional dengan nilai presentase yaitu 73,03 %.
 2. Meskipun Kategori 0 sudah memenuhi standar, masih terdapat 26,91% penggunaan antibiotik tidak rasional. Dominasi masalah pada Kategori 3B (durasi terlalu lama) Kategori 5 (tidak ada indikasi) Kategori 4 (pemilihan antibiotik tidak optimal)
 3. Rencana intervensi pada peresepan antibiotik meliputi
 - Audit penggunaan antibiotik berbasis Gyssens
 - Sosialisasi pedoman antibiotik
 - Penerapan form permintaan anitbiotik
 - Feedback langsung ke DPJP
 - Penguatan peran Tim PPRA

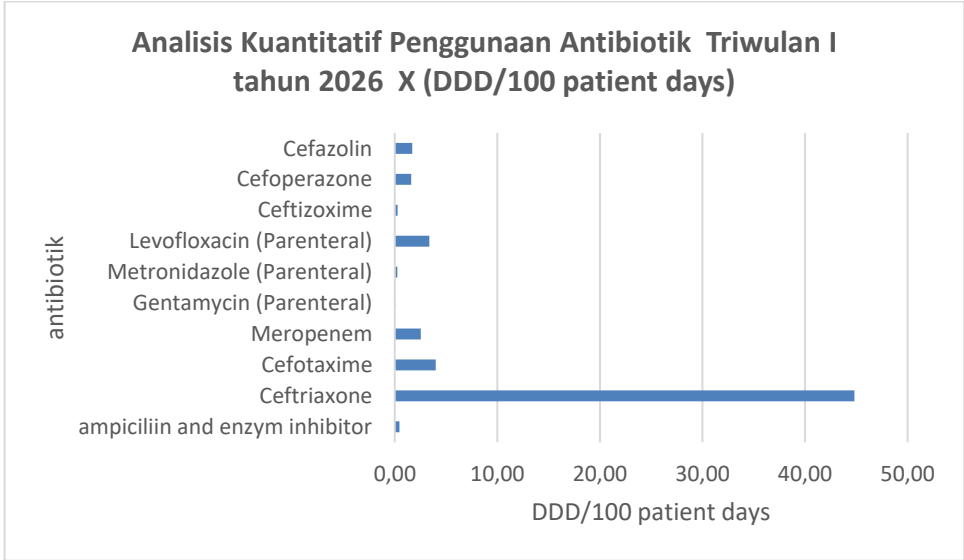
Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, maka perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
1. Menargetkan presentase kategori 0 mencapai hasil stabil di atas standar $\geq 50\%$. 2. Meningkatkan kepatuhan DPJP terhadap penerapan PPAB, terutama pada penggunaan antibiotik kategori <i>Watch</i> dan <i>Reserve</i> .	1. Sosialisasi PPAB dilakukan kepada DPJP dengan target pemahaman $>50\%$. 2. Monitoring penggunaan antibiotik di Rawat Inap dilakukan oleh apoteker Rawat Inap secara prospektif saat melakukan pelayanan farmasi klinis. Jika terdapat kasus penggunaan antibiotik irasional akan dilaporkan kepada Tim PPRA. 3. Melakukan pengkajian tentang penggunaan antibiotik irasional dengan berbagai pendekatan.	Kurangnya kepatuhan DPJP terhadap PPAB dan PPK, padahal kepatuhan tersebut berperan penting pada pelaksanaan PPRA di rumah sakit.	Meningkatkan kepatuhan DPJP pada penerapan PPAB, dengan cara : a. Sosialisasi dilakukan tepat sasaran dengan target pemahaman $>50\%$. b. Monitoring dan evaluasi penggunaan antibiotik dilakukan secara berkala oleh tim PPRA.

d. Tabel audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara kuantitatif Triwulan I (Januari-Maret)

No.	Kode DDD	Nama Antibiotik	Tot DDD	Tot DDD/rawat inap*100
1	J01CR01	ampiciliin and enzym inhibitor	5,78	0,46
2	J01DD04	Ceftriaxone	563,88	44,82
3	J01DD01	Cefotaxime	50,41	4,01
4	J01DH02	Meropenem	32,00	2,54
5	JO1GB03	Gentamycin (Parenteral)	0,42	0,03
6	J01XD01	Metronidazole (Parenteral)	3,00	0,24
7	J01MA12	Levofloxacin (Parenteral)	42,50	3,38
8	J01DD07	Ceftizoxime	3,50	0,28
9	J01DD12	Cefoperazone	20,25	1,61
	J01DB04	Cefazolin	21,33	1,70
JUMLAH			721,74	57,37

e. Grafik audit penggunaan antibiotik di Rawat Inap secara kuantitatif triwulan I



e. Analisa audit penggunaan antibiotik secara kuantitatif

Pada Triwulan I tahun 2026, antibiotik paling banyak digunakan adalah antibiotik Ceftriaxone sebesar 44,82 DDD/100 hari rawat inap. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan antibiotik di rumah sakit sangat didominasi oleh Ceftriaxone, antibiotik golongan *watch* yang merupakan antibiotik *sefalosporin* generasi ke tiga Kondisi ini mengindikasikan adanya kecenderungan penggunaan antibiotik broad-spectrum yang tinggi dan berpotensi meningkatkan risiko resistensi antimikroba apabila tidak disertai evaluasi terapi, pemeriksaan kultur, serta de-eskalasi antibiotik yang memadai.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan penggunaan antibiotik rasional, sehingga perlu dilakukan PDSA sebagai berikut.

PLAN	DO	STUDY	ACTION
Identifikasi Masalah :			
Penggunaan antibiotik tidak seimbang (<i>overuse</i> pada Ceftriaxone)	-Melakukan audit penggunaan Ceftriaxone pada pasien rawat inap. -Memberikan edukasi kepada DPJP mengenai indikasi penggunaan Ceftriaxone sesuai pedoman. -Mengoptimalkan pelaksanaan pra-otorisasi antibiotik dan pengisian formulir permintaan antibiotik.	-Membandingkan jumlah penggunaan Ceftriaxone sebelum dan sesudah intervensi. -Menilai kesesuaian penggunaan Ceftriaxone dengan pedoman rumah sakit. - Mengidentifikasi kendala yang masih menyebabkan tingginya penggunaan Ceftriaxone.	-Menetapkan rekomendasi penggunaan antibiotik yang lebih seimbang sesuai pedoman dan pola kuman rumah sakit. -Melanjutkan monitoring penggunaan Ceftriaxone secara berkala. -Melakukan sosialisasi ulang kepada DPJP yang masih memiliki tingkat penggunaan Ceftriaxone tinggi.
Antibiotik <i>broad-spectrum</i> lebih dominan dibanding <i>narrow-spectrum</i>	-Melakukan surveilans penggunaan antibiotik setiap bulan. -Melaksanakan audit penggunaan antibiotik <i>broad-spectrum</i> pada pasien rawat inap. -Memberikan edukasi kepada DPJP mengenai prinsip penggunaan antibiotik rasional.	-Persentase penggunaan antibiotik <i>broad-spectrum</i>. -Persentase penggunaan antibiotik <i>narrow-spectrum</i>. -Kepatuhan penggunaan antibiotik sesuai pedoman rumah sakit.	-Melanjutkan monitoring penggunaan antibiotik secara berkala. -Memberikan umpan balik kepada DPJP dan unit dengan penggunaan <i>broad-spectrum</i> yang tinggi. -Memperkuat kebijakan pra-otorisasi untuk antibiotik <i>broad-spectrum</i> tertentu.
Potensi Penggunaan Antibiotik Empiris Berlebihan	-Kurangnya monitoring evaluasi terapi antibiotik dalam 48–72 jam. -Kepatuhan terhadap Pedoman Penggunaan Antibiotik Rumah Sakit masih perlu ditingkatkan. - Kepatuhan terhadap Pedoman Penggunaan Antibiotik Rumah Sakit masih perlu ditingkatkan.	- Melakukan sosialisasi kepada DPJP mengenai evaluasi antibiotik empiris dalam 48–72 jam. - Melaksanakan audit penggunaan antibiotik empiris pada pasien rawat inap. - Memberikan umpan balik hasil audit kepada DPJP dan unit pelayanan terkait.	-Melaporkan hasil evaluasi kepada Komite PPRA dan manajemen rumah sakit sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.

Akar masalah yang terjadi: - Kebiasaan klinisi menggunakan Ceftriaxone sebagai terapi utama - Kurangnya pemeriksaan kultur & uji sensitivitas - Tidak dilakukan de-eskalasi terapi - Pedoman penggunaan antibiotik belum optimal diterapkan - Monitoring PPRA belum maksimal - Belum diterapkannya antibiotic time-out (48 - 72 jam) Rencana intervensi: - Sosialisasi pedoman penggunaan antibiotik - Pembatasan penggunaan Ceftriaxone (restriksi/justifikasi) - Audit penggunaan antibiotik (DDD dan kualitatif) - Optimalisasi pemeriksaan kultur - Feedback ke DPJP/unit	- Edukasi dokter terkait penggunaan antibiotik rasional - Implementasi form persetujuan antibiotik tertentu - Monitoring oleh Tim PPRA - Diskusi kasus infeksi (<i>clinical meeting</i>)	Evaluasi dilakukan dengan: - Membandingkan data DDD periode berikutnya - Melihat tren: • Penurunan penggunaan ceftriaxone • Evaluasi kesesuaian indikasi, dosis dan durasi Indikator keberhasilan: - Penurunan total DDD jika overuse terjadi	- Perketat sistem persetujuan antibiotik - Supervisi langsung oleh Tim PPRA - Penguatan regulasi (SK Direktur) - Pengembangan sistem IT (alert penggunaan antibiotik)
---	--	--	---

VII. KESIMPULAN

1. Surveilans penggunaan antibiotika secara keseluruhan di RS Prima Husada pada triwulan I tahun 2026 paling banyak terjadi pada bulan yakni sebesar 74,87 %
2. Penggunaan antibiotik tepat dan rasional memenuhi target dalam pelaporan triwulan I.
3. Peta Kuman dan Pola Kepekaan Antibiotik lokal RSPH tahun 2026 tidak mencukupi karena kurang dari 30 isolat specimen dan kurang dari 30 isolat bakteri sehingga tidak representative untuk dibuat peta kuman dan pola kepekaan antibiotik local RSPH tahun 2026.
4. Tim PPRA RSPH memakai Data Surveillance Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan Kedokteran Laboratorium Indonesia-PDS PatKLIN untuk memperkaya, melengkapi, meningkatkan dan mengembangkan peta kuman dan pola kepekaan antibiotika sesuai dengan wilayah, , jenis tipe Rumah Sakit, ruang rawat, Jenis Spesimen yang diperiksa.
5. Berdasarkan hasil tersebut diatas perlu dilakukan sosialisasi kepada DPJP tentang perlunya pemeriksaan kultur bakteri dan pemeriksaan kepekaan antibiotika untuk menentukan terapi definitive antibiotika berdasarkan bukti.

Pasuruan, 15 April 2026

Penyusun,
Ketua Komite PPRA



dr. Brilliant Margalin, Sp.PK,MARS

Mengetahui,
Direktur RS Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kes